

Acciones intersectoriales para la atención de población migrante

Breve descripción:

Este componente formativo aborda los fundamentos de la acción intersectorial en salud en contextos de movilidad humana, resaltando la influencia de los determinantes sociales y la articulación entre sectores. Se analizan el rol del sector salud, la coordinación territorial y la participación social para fortalecer la atención integral a población migrante y comunidades de acogida.

Diciembre 2025

Tabla de contenido

Introducción	4
1. Fundamentos de la acción intersectorial en salud y migración	7
1.1. Determinantes sociales y necesidad de articulación intersectorial	8
1.2. Rol del sector salud en escenarios de movilidad humana	10
1.3. Actores sectoriales e intersectoriales en el territorio	12
2. Coordinación sectorial e intersectorial para la atención de la población migrante	20
2.1. Mesas de Articulación Territorial en Salud	21
2.2. Capacidades institucionales y territoriales para la atención en salud a la población migrante	23
2.3. Comunidades sin aseguramiento en salud y acciones de respuesta	25
2.4. Participación social y enfoques diferenciales	27
3. Lineamientos técnicos y operativos para la acción intersectorial	30
3.1. Líneas de acción de la vigilancia en salud pública	31
3.2. Intervenciones colectivas e individuales en salud	33
3.3. Situaciones de interés en salud pública relacionadas con migrantes	35
3.4. Protocolos, rutas y guías técnicas vigente	37
Síntesis	40
Material Complementario	41

Glosario	42
Referencias bibliográficas	44
Créditos	48

Introducción

Este componente presenta los elementos esenciales para comprender cómo se organiza la acción intersectorial en salud frente a las dinámicas de movilidad humana. La información integra los determinantes sociales, el papel del sector salud, la articulación entre actores territoriales y las capacidades institucionales necesarias para garantizar respuestas oportunas, integrales y culturalmente pertinentes. También se abordan las estrategias de coordinación, las intervenciones colectivas e individuales, las situaciones de interés en salud pública y los protocolos vigentes que orientan la gestión territorial.

Para comprender la importancia del contenido y los temas abordados, se recomienda acceder al siguiente video.

Video 1. Acciones intersectoriales para la atención de población migrante



[Enlace de reproducción del video](#)

Síntesis del video: Acciones intersectoriales para la atención de población migrante

La acción intersectorial se reconoce como un pilar esencial para garantizar respuestas integrales frente a las realidades que viven las personas en situación de movilidad humana. La atención en salud de la población migrante implica comprender cómo determinantes como la vivienda, el empleo, la educación, el acceso a servicios y las condiciones del entorno influyen directamente en su bienestar y en sus posibilidades de inclusión en los territorios.

El sector salud cumple un rol estratégico al trabajar de manera articulada con entidades gubernamentales, instituciones educativas, organizaciones comunitarias y organismos internacionales. Esta coordinación fortalece las rutas de atención, reduce barreras y permite ofrecer respuestas diferenciadas para grupos con mayores riesgos, entre ellos mujeres gestantes, niñas, niños, adolescentes, personas mayores y comunidades sin aseguramiento en salud.

En los territorios, las Mesas de Articulación Territorial en Salud funcionan como espacios clave para analizar situaciones, distribuir responsabilidades y construir acciones conjuntas. El fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarias también mejora la gestión del riesgo, la vigilancia en salud pública y la puesta en marcha de intervenciones colectivas e individuales ajustadas al contexto local.

Asimismo, la acción intersectorial se basa en lineamientos técnicos, protocolos, rutas y guías vigentes que orientan la toma de decisiones, garantizan la calidad del

servicio y apoyan la identificación de situaciones de interés en salud pública relacionadas con la movilidad humana.

De este modo, la coordinación entre sectores se convierte en un componente esencial para proteger la salud, promover la inclusión y asegurar respuestas humanitarias que reconozcan la dignidad y los derechos de la población migrante.

1. Fundamentos de la acción intersectorial en salud y migración

La atención integral de la población migrante requiere la articulación efectiva entre sectores institucionales que aporten capacidades complementarias, con el fin de garantizar respuestas oportunas, coordinadas y centradas en derechos.

Según el Ministerio de Salud y Protección Social (2021), la movilidad humana implica desafíos en salud, protección social, inclusión socioeconómica, educación, gestión territorial y trabajo comunitario. Por ello, la coordinación intersectorial se convierte en un componente esencial para evitar la duplicidad de acciones, optimizar el uso de los recursos y garantizar el acceso oportuno a los servicios, sin barreras administrativas.

La articulación intersectorial permite integrar enfoques de salud pública, derechos humanos, gestión del riesgo, enfoque diferencial y participación comunitaria. Este proceso contribuye a que las entidades territoriales comprendan las dinámicas locales, identifiquen las necesidades específicas de la población migrante, retornada y de las comunidades de acogida, y adopten acciones concertadas basadas en evidencia.

La Organización Internacional para las Migraciones (2022) señala que la gobernanza migratoria requiere flujos de información oportunos, corresponsabilidad institucional y mecanismos técnicos de coordinación que reduzcan las vulnerabilidades y fortalezcan la capacidad de respuesta estatal, facilitando la planificación conjunta y el seguimiento de las intervenciones.

A nivel operativo, la coordinación intersectorial se materializa a través de mesas técnicas, comités territoriales, rutas integradas de atención y dispositivos comunitarios. Estas estructuras hacen posible la articulación entre la oferta institucional, los

organismos de cooperación internacional, la sociedad civil y los liderazgos comunitarios, ampliando el alcance de las intervenciones y fortaleciendo la sostenibilidad de las acciones en el territorio.

1.1. Determinantes sociales y necesidad de articulación intersectorial

Los determinantes sociales de la salud corresponden a las condiciones estructurales y a los factores intermedios que influyen en el bienestar físico, mental y social de las personas y comunidades. La Organización Mundial de la Salud define estos determinantes como las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, las cuales están condicionadas por la distribución del poder, los recursos y las oportunidades dentro de una sociedad.

En el caso de la población migrante, estos determinantes cobran especial relevancia debido a la ruptura de redes de apoyo, los cambios en el acceso a servicios, la exposición a riesgos y las condiciones de vulnerabilidad asociadas a la movilidad humana.

Entre los determinantes estructurales que influyen en la salud de la población migrante se destacan:

- ✓ Estatus migratorio y procesos de regularización.
- ✓ Disponibilidad y acceso a los servicios de salud.
- ✓ Protección social y acceso a programas de apoyo.
- ✓ Situación laboral y condiciones de empleo.
- ✓ Condiciones de pobreza y exclusión social.
- ✓ Capacidad institucional y normativa del territorio.

Estos factores condicionan directamente el acceso a los servicios y la capacidad de respuesta de las entidades territoriales, dependiendo de la disponibilidad de recursos humanos, técnicos y financieros.

Asimismo, los determinantes intermedios influyen en la experiencia de integración y bienestar de la población migrante, entre ellos:

- ✓ Redes familiares y comunitarias.
- ✓ Capital social y vínculos de apoyo.
- ✓ Condiciones de vivienda.
- ✓ Seguridad alimentaria.
- ✓ Acceso a educación.
- ✓ Entornos comunitarios seguros.
- ✓ Barreras idiomáticas, estigmatización y discriminación.

La ruptura de redes, la estigmatización y las barreras culturales afectan de manera significativa el bienestar emocional y social, lo que exige respuestas integrales desde distintos sectores.

La articulación intersectorial se convierte en una necesidad estructural, ya que ningún sector por sí solo cuenta con la capacidad técnica, operativa y normativa para responder a la complejidad de la movilidad humana. Por ejemplo:

- ✓ El sector salud aporta atención básica, urgencias, promoción y prevención.
- ✓ El sector educación facilita la integración escolar.
- ✓ La protección social identifica y gestiona riesgos.
- ✓ El sector productivo fortalece oportunidades laborales.

- ✓ Las entidades territoriales activan rutas de atención, remisión y seguimiento.

En este sentido, los determinantes sociales obligan a las instituciones a desarrollar estrategias de trabajo conjunto que permitan:

- ✓ Identificar tempranamente situaciones de vulnerabilidad.
- ✓ Activar rutas integrales de atención.
- ✓ Definir responsabilidades sectoriales.
- ✓ Implementar acciones complementarias

La articulación intersectorial fortalece la eficiencia de la respuesta institucional y mejora la capacidad de los territorios para gestionar de manera sostenible los efectos de la migración, promoviendo el bienestar y la inclusión de la población migrante y de las comunidades de acogida.

1.2. Rol del sector salud en escenarios de movilidad humana

El sector salud, en el contexto de la movilidad humana, constituye un eje estratégico para garantizar la protección y el bienestar integral de las poblaciones migrantes, retornadas y comunidades de acogida. El proceso migratorio expone a las personas a múltiples riesgos asociados a condiciones inadecuadas de vivienda, barreras de acceso a los servicios de salud, dificultades idiomáticas, irregularidad migratoria, estigmatización, discriminación y ruptura de redes sociales. En este escenario, el sector salud asume un rol que trasciende la atención asistencial y se configura como un actor articulador, orientador y garante de derechos fundamentales.

Desde la perspectiva de la Organización Mundial de la Salud, los sistemas de salud deben establecer respuestas integradas, equitativas y culturalmente pertinentes para reducir las desigualdades asociadas a la migración. Estas respuestas se concretan en cuatro ámbitos:

- 1) Garantía de acceso oportuno a los servicios de salud.
- 2) Avance hacia la cobertura universal.
- 3) Fortalecimiento de la vigilancia en salud pública.
- 4) Reducción de brechas sociales en salud.

En el contexto colombiano, el sector salud incorpora estos principios a través de la Ley Estatutaria 1751 de 2015, que reconoce la salud como un derecho fundamental de aplicación universal, sin discriminación por nacionalidad o estatus migratorio.

Una de las funciones centrales del sector salud es garantizar el acceso efectivo a los servicios, independientemente de la situación migratoria. Instrumentos normativos como el Decreto 216 de 2021 (Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos) y la Circular 024 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social establecen la obligación de asegurar la atención inicial de urgencias, la vacunación, el control prenatal y el acceso a programas de promoción y prevención.

De igual manera, el sector salud cumple un rol preventivo y protector al promover entornos seguros y saludables, mediante:

- ✓ Estrategias de atención psicosocial.
- ✓ Campañas de información y educación en salud.
- ✓ Acciones comunitarias para la reducción del estigma.
- ✓ Promoción de la convivencia intercultural.

Adicionalmente, desempeña una función pedagógica al fortalecer la alfabetización en salud de la población migrante, facilitando información clara sobre derechos, rutas de atención, afiliación al sistema y signos de alarma en salud física y mental. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2020) resalta que este proceso mejora la adherencia a los tratamientos y favorece la integración comunitaria.

En síntesis, el rol del sector salud en escenarios de movilidad humana es integral y multidimensional. Abarca la garantía de derechos, la vigilancia en salud pública, la atención psicosocial, la coordinación intersectorial y la promoción de entornos protectores, consolidándose como un eje estratégico para la respuesta territorial frente a las necesidades de la población migrante.

1.3. Actores sectoriales e intersectoriales en el territorio

Los actores sectoriales e intersectoriales desempeñan un papel fundamental en la respuesta institucional frente a la movilidad humana. En Colombia, estos actores se organizan de acuerdo con las competencias establecidas en normas como la Ley 715 de 2001, la Ley 1751 de 2015 y la Ley 2136 de 2021 (Política Integral Migratoria), así como en los lineamientos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Su función es garantizar la atención integral, la coordinación operativa, la activación de rutas de atención y la implementación de estrategias de integración para la población migrante, retornada y comunidades de acogida.

La siguiente tabla presenta los principales actores involucrados en la respuesta territorial:

Tabla 1. Actores fundamentales en la atención a la población en movilidad humana

Sector	Actor	Función principal
Salud	Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS)	Define lineamientos técnicos, políticas públicas y orientaciones para la atención integral, afiliación, vigilancia en salud pública y modelos de atención territorial.
Salud	Secretarías Departamentales y Municipales de Salud	Gestionan la respuesta territorial, activan rutas de atención, supervisan el aseguramiento y coordinan las Mesas de Articulación Territorial.
Salud	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS)	Garantizan la prestación de servicios, atención de urgencias, vacunación, salud materna, atención psicosocial y remisiones interinstitucionales.

Sector	Actor	Función principal
Salud	Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB)	Facilitan la afiliación de población con Permiso por Protección Temporal (PPT) y garantizan la cobertura en el sistema de salud.
Social y protección	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)	Atiende a niños, niñas y adolescentes migrantes mediante acciones de protección, salud mental, nutrición y fortalecimiento de entornos protectores.
Social y protección	Unidad para las Víctimas	Activa rutas psicosociales en casos de doble afectación, vinculando migración y conflicto armado.
Social y protección	Departamento para la Prosperidad Social (DPS)	Implementa programas de apoyo social, transferencias monetarias y estrategias de inclusión.

Sector	Actor	Función principal
Social y protección	Alcaldías y Gobernaciones	Lideran la articulación territorial, convocan mesas intersectoriales y coordinan acciones institucionales.
Educación	Ministerio de Educación Nacional (MEN)	Coordina procesos de inclusión escolar, permanencia educativa y estrategias de integración para niños, niñas y adolescentes migrantes.
Educación	Instituciones educativas	Identifican barreras de acceso, activan rutas de protección y desarrollan acciones comunitarias.
Humanitario e internacional	Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)	Brinda asistencia en protección, fortalecimiento institucional y apoyo en procesos de integración.

Sector	Actor	Función principal
Humanitario e internacional	Organización Internacional para las Migraciones (OIM)	Coordina acciones en salud, inclusión, retornos voluntarios y fortalecimiento institucional.
Humanitario e internacional	Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)	Desarrolla acciones en educación, protección y salud mental para la infancia migrante.
Humanitario e internacional	Cruz Roja	Apoya en primeros auxilios, acompañamiento psicosocial y reunificación familiar.
Comunitario y social	Líderes comunitarios	Identifican riesgos, promueven la integración y fortalecen las redes comunitarias.
Comunitario y social	Organizaciones comunitarias y sociales	Promueven la participación, el diálogo

Sector	Actor	Función principal
		intercultural y el apoyo mutuo.
Comunitario y social	Iglesias y organizaciones religiosas	Brindan asistencia humanitaria, orientación emocional y apoyo social.

La participación de múltiples actores institucionales, sociales y comunitarios exige altos niveles de coordinación, claridad en la definición de roles y responsabilidades, así como mecanismos estables de articulación intersectorial. De acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social y de la Organización Internacional para las Migraciones, uno de los principales desafíos en los territorios es la falta de integración efectiva de la información, lo que puede generar duplicidad de acciones, dispersión de esfuerzos y baja efectividad en la respuesta institucional. La ausencia de sistemas de información interoperables dificulta el seguimiento de los casos y la continuidad de los procesos de atención.

Entre los retos más frecuentes de la articulación intersectorial se identifican:

- 1) La duplicidad de acciones por falta de información compartida y ausencia de protocolos unificados.

- 2) Las limitaciones presupuestales que afectan la cobertura, calidad y sostenibilidad de las intervenciones.
- 3) Las barreras administrativas que retrasan la activación de rutas y el acceso oportuno a los servicios.
- 4) La fragmentación territorial, que genera respuestas desiguales entre zonas urbanas, rurales y de frontera.
- 5) La desigualdad en la capacidad operativa entre municipios, relacionada con la disponibilidad de talento humano, infraestructura y recursos técnicos.

A pesar de estos desafíos, la articulación entre actores sectoriales e intersectoriales permite la construcción de respuestas más integrales, coordinadas y sostenibles, orientadas al bienestar de la población migrante y de las comunidades de acogida. Esta articulación contribuye a:

- ✓ La generación de rutas de atención unificadas que facilitan la orientación y el acceso a los servicios.
- ✓ La optimización de recursos técnicos, financieros y humanos mediante la planificación conjunta.
- ✓ El fortalecimiento de la capacidad de respuesta territorial a través de procesos de formación y asistencia técnica.
- ✓ La participación de la cooperación internacional como un recurso estratégico para ampliar la cobertura y calidad de las intervenciones.
- ✓ La mejora del acceso efectivo a los servicios de salud, protección social, educación y apoyo psicosocial.

En consecuencia, la acción intersectorial se consolida como un eje fundamental para reducir la vulnerabilidad, fortalecer la protección de derechos y promover procesos sostenibles de integración social de la población en movilidad humana.

2. Coordinación sectorial e intersectorial para la atención de la población migrante

La movilidad humana plantea desafíos que superan la capacidad de respuesta de un solo sector, dado que involucra dimensiones sanitarias, sociales, educativas, económicas y comunitarias que requieren intervenciones integrales, continuas y sostenibles. De acuerdo con la Política Integral Migratoria establecida en la Ley 2136 de 2021, la atención a la población migrante debe estructurarse a partir de acciones coordinadas entre sectores, niveles de gobierno y actores territoriales, garantizando el acceso efectivo a servicios, la protección de derechos y la gestión oportuna de los riesgos en salud y protección social.

En este contexto, organismos internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y ACNUR han señalado que la articulación intersectorial es indispensable para atender de manera integral las necesidades de las personas en situación de movilidad humana, bajo principios de dignidad, protección, enfoque diferencial, interculturalidad y participación comunitaria (OIM y ACNUR). La coordinación sectorial e intersectorial se consolida, así, como un eje estratégico para garantizar la protección efectiva, el acceso a servicios esenciales y la atención adecuada de las necesidades de la población migrante, retornada y de las comunidades de acogida. Estos procesos permiten articular recursos, capacidades técnicas y competencias institucionales para enfrentar las situaciones complejas derivadas del tránsito, asentamiento temporal o permanencia en los territorios.

Asimismo, se desarrollan los fundamentos operativos y estratégicos de la articulación intersectorial en salud, abordando el funcionamiento de las Mesas de Articulación Territorial como espacios formales de coordinación. La Resolución 521 de

2020 establece lineamientos para la organización territorial y la coordinación con sectores como educación, protección social, justicia, gestión del riesgo y cooperación internacional, con el fin de garantizar respuestas oportunas, pertinentes y culturalmente adecuadas para la población migrante (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020).

La identificación de capacidades institucionales, el análisis de las brechas de atención de las personas sin aseguramiento y la incorporación de enfoques de participación social orientan la toma de decisiones en los territorios. De igual manera, se establece cómo los diferentes sectores convergen en la planeación, ejecución, monitoreo y evaluación de acciones, fortaleciendo la gobernanza local y la capacidad de respuesta institucional frente a las dinámicas de la movilidad humana.

2.1. Mesas de Articulación Territorial en Salud

Las Mesas de Articulación Territorial en Salud (MATS) representan un mecanismo clave para la gestión articulada de la respuesta institucional frente a la movilidad humana. Su creación se fundamenta en los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, la Política Integral Migratoria establecida en la Ley 2136 de 2021 y los principios del Sistema General de Seguridad Social en Salud consagrados en la Ley 1751 de 2015. Estos espacios permiten integrar información, capacidades y decisiones entre diversos sectores para garantizar una atención integral, oportuna y pertinente.

Las Mesas de Articulación Territorial en Salud están conformadas por actores estratégicos del orden territorial e institucional, tales como:

- ✓ Secretaría de Salud (liderazgo técnico).

- ✓ Oficina de Gestión Social.
- ✓ Secretaría de Educación.
- ✓ Secretaría de Gobierno.
- ✓ Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
- ✓ Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
- ✓ Migración Colombia.
- ✓ Defensoría del Pueblo.
- ✓ Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUE).
- ✓ Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) públicas y privadas.
- ✓ Organismos de cooperación internacional.
- ✓ Organizaciones comunitarias y liderazgos de población migrante.

El propósito principal de las MATS es coordinar, articular y orientar las acciones operativas del territorio para responder a las necesidades en salud de la población migrante y retornada, promoviendo un enfoque de derechos y reduciendo las brechas de acceso derivadas del estatus migratorio, la vulnerabilidad socioeconómica y las barreras administrativas.

Entre las funciones esenciales de las Mesas de Articulación Territorial en Salud se encuentran:

- 1) Analizar la situación de salud con base en información epidemiológica, demográfica y social del territorio.
- 2) Definir prioridades de atención a partir de alertas tempranas, eventos emergentes y brechas críticas.

- 3) Unificar rutas de atención, clarificando responsabilidades entre IPS, EAPB, entes territoriales y actores de cooperación internacional.
- 4) Coordinar acciones intersectoriales entre salud, educación, protección social, vivienda, migración, justicia y actores humanitarios.
- 5) Promover la participación comunitaria mediante la inclusión de líderes migrantes y organizaciones territoriales.
- 6) Gestionar recursos institucionales y de cooperación destinados a la atención de la movilidad humana.
- 7) Realizar seguimiento a la implementación de lineamientos, protocolos y acuerdos operativos.

La composición multisectorial de las MATS permite construir una comprensión integral del contexto territorial, fortaleciendo la capacidad de respuesta institucional. La evidencia disponible indica que la coordinación intersectorial mejora la eficiencia, amplía la cobertura y acelera la atención oportuna de la población migrante.

2.2. Capacidades institucionales y territoriales para la atención en salud a la población migrante

Las capacidades institucionales y territoriales corresponden al conjunto de recursos, procesos y condiciones que permiten a los entes del sector salud y a otros sectores garantizar la atención integral de la población migrante, retornada y de acogida. Estas capacidades abarcan infraestructura, gestión administrativa, coordinación intersectorial, talento humano, redes comunitarias y mecanismos de articulación territorial.

a) Capacidades estructurales

Según el Ministerio de Salud y Protección Social, estas capacidades son determinantes para asegurar la respuesta inicial en los territorios:

- ✓ Infraestructura física disponible (hospitales, puestos de salud, centros de atención extramural).
- ✓ Sistemas de información en salud, como SIVIGILA, RUAF, SISMUESTRAS y tableros territoriales de análisis.
- ✓ Redes de prestadores y servicios habilitados según la normatividad vigente.
- ✓ Capacidad instalada en urgencias, vacunación, salud materna, salud mental y atención a población sin aseguramiento.

Los municipios con baja infraestructura o zonas rurales dispersas tienden a enfrentar mayores barreras en atención oportuna, vigilancia epidemiológica y continuidad del cuidado.

b) Capacidades organizacionales y técnicas

Estas capacidades fortalecen la articulación sectorial e intersectorial:

- ✓ Existencia de Planes Territoriales de Salud con componentes específicos de movilidad humana.
- ✓ Protocolos unificados para atención de personas migrantes, retornadas y refugiadas.
- ✓ Funcionamiento de Mesas de Articulación Territorial en Salud (MATS).
- ✓ Equipos técnicos formados en enfoque diferencial, atención psicosocial, interculturalidad y normativa migratoria.

- ✓ Gestión administrativa y financiera que facilita coordinación entre EAPB, IPS, entes territoriales y cooperación internacional.

La Organización Internacional para las Migraciones (2020) señala que la formación del talento humano es clave para garantizar intervenciones culturalmente pertinentes y alineadas con estándares nacionales e internacionales.

c) Capacidades operativas y comunitarias

Estas capacidades permiten ampliar la cobertura y reducir las brechas de acceso:

- ✓ Acciones extramurales y brigadas integrales en zonas urbanas, rurales y de frontera.
- ✓ Movilización territorial mediante líderes comunitarios, gestores interculturales y redes de apoyo migrante.
- ✓ Coordinación efectiva entre secretarías, EPS, IPS, cooperación internacional y organizaciones sociales.
- ✓ Sistemas de referencia y contrareferencia que permitan atención continua.
- ✓ Participación social a través de organizaciones comunitarias, veedurías y liderazgos migrantes.

El fortalecimiento de estas capacidades es esencial para mejorar la eficiencia operativa, garantizar acceso equitativo y cumplir los compromisos de la Política Integral Migratoria (Ley 2136 de 2021) y los estándares de la OPS.

2.3. Comunidades sin aseguramiento en salud y acciones de respuesta

La presencia de comunidades sin aseguramiento en salud constituye un desafío estructural para los territorios, especialmente en zonas con alta concentración de población migrante y retornada. La falta de afiliación al Sistema General de Seguridad

Social en Salud (SGSSS) se relaciona con movilidad constante, irregularidad migratoria, desconocimiento de los procedimientos de afiliación, barreras idiomáticas y diferencias culturales. Según el Ministerio de Salud y Protección Social, esta situación incrementa el riesgo de no recibir atención oportuna, limita la continuidad del cuidado y profundiza las brechas de acceso entre comunidades receptoras y población en movilidad humana.

Las acciones de respuesta deben alinearse con la Ley Estatutaria 1751 de 2015, la Ley 2136 de 2021 y el Decreto 064 de 2020, que garantizan la atención inicial en salud independientemente del estatus migratorio y orientan la afiliación progresiva de quienes permanecen en el territorio. En concordancia con las orientaciones de la OPS, los entes territoriales deben fortalecer estrategias como:

- ✓ Jornadas de afiliación y registro de población migrante.
- ✓ Puntos de orientación en salud y articulación con Migración Colombia.
- ✓ Gestores interculturales para facilitar información y acompañamiento.
- ✓ Brigadas extramurales en zonas urbanas, rurales y de frontera.
- ✓ Coordinación con EPS receptoras para garantizar continuidad de servicios.
- ✓ Activación de rutas de urgencias, atención materna, vacunación, tamizajes y apoyo psicosocial.

Adicionalmente, el abordaje de comunidades sin aseguramiento requiere estrategias colectivas que fortalezcan la confianza institucional y promuevan la integración social. Según la OIM, acciones como:

- ✓ Sensibilización comunitaria y educación sobre derechos en salud.
- ✓ Entrega de instructivos multilingües y materiales pedagógicos accesibles.
- ✓ Acompañamiento de líderes comunitarios y redes de apoyo migrante.

- ✓ Articulación con sectores como educación, protección social, registraduría, gobiernos locales y cooperación internacional.

Estas acciones favorecen el acceso oportuno, aumentan la probabilidad de afiliación y permiten una respuesta integral frente a las necesidades de la población migrante. En conjunto, contribuyen a disminuir desigualdades y garantizar el ejercicio pleno del derecho a la salud en contextos de movilidad humana.

2.4. Participación social y enfoques diferenciales

La participación social constituye un eje fundamental para fortalecer la salud pública y la atención dirigida a población migrante, retornada y de acogida. Para facilitar su comprensión, a continuación, se presentan sus ideas clave:

1) Participación social

- ✓ Facilita que las comunidades influyan en la identificación de necesidades, la planeación territorial y la evaluación de las respuestas institucionales (Ministerio de Salud y Protección Social).
- ✓ Promueve el reconocimiento mutuo entre comunidades, especialmente en contextos de movilidad humana, reduciendo tensiones y favoreciendo procesos de integración.
- ✓ Se materializa en espacios como Mesas de Participación Social, comités comunitarios y veedurías ciudadanas, los cuales fortalecen la corresponsabilidad, la transparencia y la confianza comunitaria.

2) Enfoque diferencial

- ✓ Permite que las intervenciones se ajusten a las características de grupos como mujeres, niños, personas mayores, población LGBTIQ+, grupos étnicos, víctimas del conflicto armado y personas con discapacidad.
- ✓ La Política de Participación Social en Salud (Resolución 2063 de 2017) orienta acciones para reconocer desigualdades históricas y responder a necesidades particulares.
- ✓ En el caso de población migrante, este enfoque facilita la adaptación cultural, la comunicación intercultural y la valoración de trayectorias migratorias diversas.

3) Derechos, interculturalidad y participación

- ✓ Los enfoques de derechos e interculturalidad garantizan una atención digna, respetuosa y alineada con estándares internacionales.
- ✓ La ACNUR (2023) destaca que los procesos participativos permiten visibilizar riesgos, identificar barreras de acceso y priorizar acciones con base en experiencias reales.
- ✓ La inclusión de líderes migrantes, organizaciones comunitarias y actores territoriales contribuye a fortalecer capacidades locales y a consolidar intervenciones más pertinentes, sostenibles y coherentes con la realidad sociocultural.

En conjunto, la participación social y los enfoques diferenciales consolidan una respuesta más humana, coherente y contextualizada frente a los retos de la movilidad

humana. Estos elementos no solo fortalecen la articulación entre instituciones y comunidades, sino que también aseguran que las acciones en salud se construyan desde la diversidad, la corresponsabilidad y el respeto por las trayectorias de vida de las personas migrantes, retornadas y de acogida. De esta manera, se promueven intervenciones más inclusivas, sostenibles y centradas en las necesidades reales de los territorios.

3. Lineamientos técnicos y operativos para la acción intersectorial

La acción intersectorial constituye uno de los pilares para la gestión territorial en salud y para la atención integral de la población migrante, retornada y de acogida. Estos lineamientos permiten articular instituciones, definir responsabilidades y orientar intervenciones que garanticen el cumplimiento del marco normativo nacional e internacional. Según el Ministerio de Salud y Protección Social, la articulación sectorial se fundamenta en principios de oportunidad, integralidad y complementariedad, fortaleciendo la capacidad institucional para responder de manera efectiva a las necesidades del territorio.

Para hacerlo más claro, se destacan los elementos esenciales que guían esta acción intersectorial:

- ✓ **Vigilancia en salud pública:** incluye la identificación de eventos de interés epidemiológico, el análisis de riesgos y la activación de rutas de respuesta acordes con las dinámicas de movilidad humana.
- ✓ **Intervenciones colectivas e individuales:** se orientan por protocolos unificados y rutas de atención que garantizan oportunidad, continuidad y pertinencia cultural.
- ✓ **Coordinación entre sectores e instituciones:** involucra secretarías territoriales, autoridades migratorias, cooperación internacional, EPS, IPS y gobiernos locales para asegurar acciones coherentes y complementarias.
- ✓ **Enfoques diferenciales y de derechos:** incorporan variables como género, edad, condición migratoria, discapacidad o pertenencia étnica, asegurando intervenciones más justas y pertinentes.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) resalta la importancia de adaptar los procesos de vigilancia, atención y respuesta a las particularidades de la movilidad humana, integrando mecanismos de coordinación técnica y operativa con actores nacionales y territoriales.

En conjunto, estos lineamientos proporcionan un marco sólido para orientar la gestión territorial, armonizar esfuerzos entre sectores y garantizar una respuesta efectiva, oportuna y coherente frente a los retos que plantea la movilidad humana en el país.

3.1. Líneas de acción de la vigilancia en salud pública

La vigilancia en salud pública constituye una herramienta central para identificar, analizar y actuar frente a los eventos que afectan la salud colectiva. De acuerdo con el Decreto 780 de 2016 y los lineamientos del Instituto Nacional de Salud (INS, 2023), la vigilancia implica la recolección sistemática, el análisis oportuno, la interpretación y la difusión de información epidemiológica para orientar acciones de prevención, control y mitigación de riesgos.

En contextos de movilidad humana, estas acciones deben integrar variables como nacionalidad, condición migratoria, trayectorias de desplazamiento, barreras de acceso, determinantes sociales y condiciones del entorno territorial. Las principales líneas de acción aplicables a población migrante, retornada y comunidades de acogida incluyen:

- a) **Vigilancia rutinaria:** seguimiento continuo a los Eventos de Interés en Salud Pública (EISP), incluyendo enfermedades transmisibles, patologías crónicas, salud mental, violencias, salud materno-perinatal y vacunación.

Esta línea permite identificar cambios en el comportamiento epidemiológico y ajustar respuestas en tiempo real.

- b) **Vigilancia centinela:** implementación de puntos estratégicos en zonas fronterizas, corredores migratorios y territorios con alta movilidad. Su propósito es detectar tendencias, alertas tempranas y circulación de agentes infecciosos en grupos altamente móviles.
- c) **Vigilancia comunitaria:** participación de líderes comunitarios, gestores interculturales y redes de apoyo migrante para identificar señales tempranas de riesgo, brotes inusuales o barreras de acceso. Es especialmente útil en asentamientos informales, zonas periféricas y territorios sin presencia institucional permanente.
- d) **Análisis de riesgo territorial:** integración de datos migratorios, información epidemiológica, determinantes sociales y condiciones geográficas para orientar decisiones intersectoriales. Esta línea permite priorizar intervenciones, asignar recursos y anticipar escenarios de riesgo (INS, 2023).

El fortalecimiento de la vigilancia para población migrante requiere coordinación permanente con Migración Colombia, entes territoriales, EPS, IPS y cooperación internacional, quienes aportan información sobre flujos migratorios, asentamientos, grupos vulnerables y nuevas dinámicas de desplazamiento. Esta articulación mejora la capacidad de respuesta local, facilita la activación temprana de acciones, reduce brechas de acceso y permite desarrollar intervenciones más oportunas, pertinentes y culturalmente adaptadas.

3.2. Intervenciones colectivas e individuales en salud

Las intervenciones colectivas e individuales establecen el marco operativo de la respuesta en salud dirigida a la población migrante, retornada y comunidades de acogida. De acuerdo con la Resolución 518 de 2015 y la Resolución 3280 de 2018, estas intervenciones se organizan bajo el enfoque de gestión del riesgo e integran acciones de promoción, prevención, atención, seguimiento y protección de derechos.

- a) Intervenciones colectivas:** se implementan en grupos, comunidades o territorios y buscan transformar determinantes sociales, fortalecer capacidades locales y mejorar la respuesta institucional. Dentro de las acciones más relevantes se incluyen:
- ✓ Jornadas de educación y alfabetización en salud (acceso al sistema, autocuidado, derechos y deberes).
 - ✓ Acciones extramurales y brigadas integrales en asentamientos, zonas rurales dispersas y pasos fronterizos.
 - ✓ Fortalecimiento de redes de apoyo comunitario, incluyendo líderes migrantes y gestores interculturales.
 - ✓ Programas comunitarios en salud mental, con enfoque psicosocial y estrategias de primer apoyo emocional.
 - ✓ Diagnósticos participativos y mapeos comunitarios para identificar riesgos, barreras de acceso y necesidades prioritarias.
 - ✓ Promoción de convivencia, cohesión social e integración comunitaria, incluyendo actividades culturales y pedagógicas.
 - ✓ Intersectorialidad territorial, articulando salud, protección social, educación, migración y cooperación internacional.

Estas acciones permiten abordar problemáticas comunes como el desconocimiento del sistema de salud, las barreras lingüísticas, la discriminación y la desconfianza institucional, factores señalados como críticos por la OPS.

b) Intervenciones individuales: se orientan a la atención directa de personas y familias, priorizando la oportunidad, la continuidad del cuidado y la garantía de derechos. Estas incluyen:

- ✓ Valoración clínica, psicosocial y de riesgo, especialmente en gestantes, menores de edad, sobrevivientes de violencia y personas con enfermedades crónicas.
- ✓ Acompañamiento emocional y primeros auxilios psicológicos ante situaciones de crisis o trayectorias migratorias traumáticas.
- ✓ Activación de rutas de atención en urgencias, salud materna, vacunación, violencia, salud mental y enfermedades transmisibles.
- ✓ Seguimiento de casos priorizados, articulado con EPS, IPS, equipos extramurales y actores comunitarios.
- ✓ Remisiones especializadas y contrarreferencias, garantizando continuidad del cuidado y reducción de barreras administrativas.
- ✓ Acciones de protección de derechos, incluyendo orientación jurídica básica, canalización a programas sociales y acceso a afiliación cuando aplique.

El enfoque diferencial, establecido en normativas como la Ley 1098 de 2006 (infancia), Ley 1257 de 2008 (violencias contra la mujer) y Ley 1616 de 2013 (salud mental), es de aplicación obligatoria en la ejecución de las intervenciones. Este enfoque garantiza:

- ✓ Atención ajustada a edad, género, orientación sexual e identidad de género.
- ✓ Reconocimiento de pertenencia étnica y prácticas culturales.
- ✓ Adaptaciones para personas con discapacidad o condiciones especiales de vulnerabilidad.

En el caso de la población migrante, las intervenciones deben incorporar:

- ✓ Mediación intercultural y apoyo de intérpretes o gestores bilingües.
- ✓ Adaptación cultural de mensajes de salud y materiales educativos multilingües.
- ✓ Consideración de trayectorias migratorias, que pueden incluir duelos, rupturas familiares, violencia o precariedad económica.
- ✓ Revisión de determinantes sociales, como irregularidad migratoria, hacinamiento, pobreza o informalidad laboral.

3.3. Situaciones de interés en salud pública relacionadas con migrantes

Las Situaciones de Interés en Salud Pública (SISP) corresponden a eventos, condiciones o riesgos que afectan de manera significativa la salud colectiva y requieren vigilancia reforzada, análisis permanente y acciones de respuesta inmediata. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS, 2023) y la OPS, en los contextos de movilidad humana estas situaciones pueden intensificarse debido a condiciones de vulnerabilidad social, irregularidad migratoria, barreras de acceso y dificultades en la continuidad del cuidado. Entre las SISP más relevantes en población migrante se encuentran:

- ✓ **Enfermedades transmisibles:** tuberculosis, infección por VIH, sífilis gestacional y congénita, hepatitis virales, enfermedades prevenibles por vacunas, COVID-19 y otras infecciones respiratorias agudas.
- ✓ **Salud mental:** afectaciones emocionales relacionadas con el proceso migratorio, duelo migratorio, ansiedad, depresión, estrés postraumático, consumo de sustancias y riesgo suicida.
- ✓ **Violencias:** violencia basada en género, explotación laboral, trata de personas, violencia intrafamiliar y violencias sexuales, en concordancia con la Ley 1257 de 2008 y la Ley 1719 de 2014.
- ✓ **Salud materno-perinatal:** inicio tardío del control prenatal, riesgo obstétrico en gestantes sin aseguramiento, dificultades en acceso a parto seguro y baja adherencia a controles postnatales.
- ✓ **Enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT):** hipertensión, diabetes, enfermedades cardiometabólicas y descompensaciones clínicas por falta de acceso a tratamiento, interrupción del cuidado o desabastecimiento de medicamentos.
- ✓ **Condiciones asociadas a determinantes sociales:** desnutrición, inseguridad alimentaria, hacinamiento, insalubridad, exposición a riesgos ambientales y trabajos de alto riesgo.

El análisis de las SISP permite orientar decisiones intersectoriales, priorizar recursos y diseñar intervenciones diferenciales para los grupos en mayor vulnerabilidad. Su abordaje requiere una respuesta articulada con entidades como el ICBF, comisarías de familia, sector educativo, vivienda, primera infancia, autoridades migratorias y cooperación internacional. Esta coordinación facilita la activación de rutas

integrales de atención, la garantía de derechos y la mitigación oportuna de riesgos, fortaleciendo la capacidad territorial para responder a las dinámicas de la movilidad humana.

3.4. Protocolos, rutas y guías técnicas vigente

Los protocolos, rutas y guías técnicas establecen los procedimientos necesarios para garantizar una atención oportuna, integral y coordinada en los territorios. Estos instrumentos orientan la respuesta institucional frente a la población migrante, retornada y de acogida, definiendo responsabilidades, flujos de atención y mecanismos de articulación. Uno de los elementos centrales es el conocimiento de la ruta de atención en salud para migrantes y retornados, la cual incluye:

- ✓ Orientación inicial sobre derechos en salud, rutas de acceso y oferta disponible en el territorio.
- ✓ Afiliación cuando aplica, incluyendo titulares de ESTP, Permiso por Protección Temporal (PPT) y personas nacionalizadas.
- ✓ Atención de urgencias sin restricción, conforme a la Ley Estatutaria 1751 de 2015 y el Decreto 780 de 2016.
- ✓ Remisión y contrarreferencia según la necesidad clínica o psicosocial.
- ✓ Seguimiento territorial, articulado entre EPS, IPS y entidades locales de salud.

En materia de salud mental, la Ley 1616 de 2013, la Resolución 4886 de 2018 (Política Nacional de Salud Mental) y la Ley 2460 de 2025 establecen los lineamientos técnicos y normativos para la identificación, atención, acompañamiento y seguimiento de necesidades emocionales. La Ley 2460 de 2025, vigente desde el 16 de junio de 2025, redefine la salud mental como un derecho fundamental, elimina la remisión

obligatoria para acceder a psicología clínica, refuerza la atención comunitaria e impulsa estrategias de prevención del consumo de sustancias y del suicidio. Estos lineamientos se sustentan en principios de dignidad humana, enfoque de derechos, interculturalidad y atención integral.

En el contexto migratorio, estas directrices permiten organizar respuestas institucionales culturalmente pertinentes y sensibles a las trayectorias migratorias. Para ello, se priorizan intervenciones como:

- ✓ Atención psicosocial.
- ✓ Intervención en crisis.
- ✓ Acompañamiento emocional.
- ✓ Activación de rutas de protección.
- ✓ Rutas intersectoriales coordinadas.

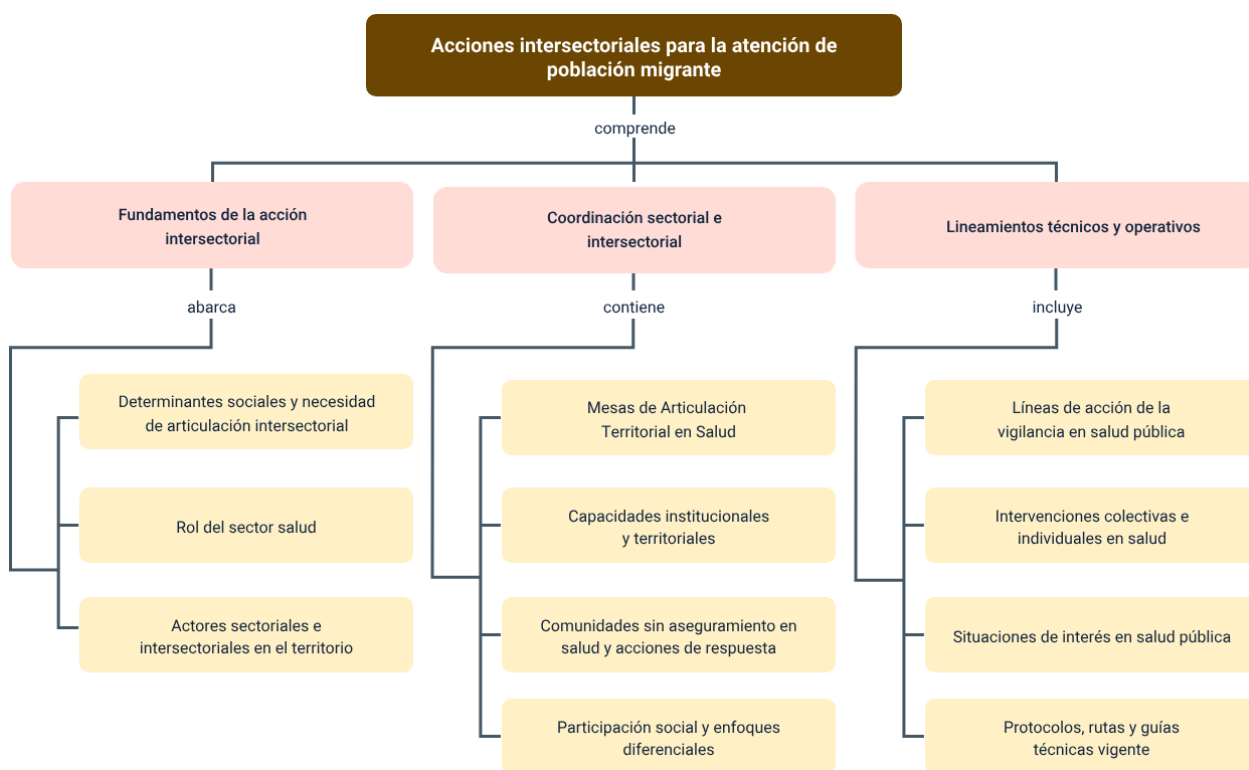
Las rutas intersectoriales articulan acciones entre salud, educación, protección social, justicia, bienestar familiar y cooperación internacional, garantizando respuestas integrales frente a riesgos que afectan a personas en movilidad humana. Desde la Resolución 521 de 2020 y el Decreto 780 de 2016, se establece la obligación de asegurar acceso efectivo a servicios sin importar el estatus migratorio, promover la continuidad del cuidado y unificar criterios operativos entre instituciones, evitando duplicación de esfuerzos y fortaleciendo la gobernanza territorial.

Los diferentes instrumentos estructurados como protocolos, flujogramas, rutas de atención, mecanismos de coordinación y guías técnicas, permiten que la atención territorial sea homogénea, basada en evidencia y alineada con el marco normativo nacional e internacional. De esta manera, se garantiza que la respuesta institucional sea

técnica, coherente y adaptada a los riesgos diferenciados presentes en escenarios de movilidad humana.

Síntesis

Este componente formativo aborda los principios y mecanismos de articulación intersectorial para la atención integral de la población migrante, destacando la coordinación entre instituciones, las capacidades territoriales, la participación comunitaria y los lineamientos técnicos y operativos que orientan las intervenciones individuales y colectivas en salud pública, con el fin de fortalecer respuestas oportunas, integrales y basadas en enfoques diferenciales.



Material Complementario

Tema	Referencia	Tipo de material	Enlace del recurso
Rol del sector salud en escenarios de movilidad humana	MinSaludCol. (2022). Acompañamiento psicosocial, Logros del sector salud en población migrante. [Video]. YouTube.	Video	https://www.youtube.com/watch?v=yqY5aVdRsNM
Intervenciones colectivas e individuales en salud	ESE Manuel Castro Tovar. (2018). Plan de Intervenciones Colectivas [Video]. YouTube.	Video	https://www.youtube.com/watch?v=MALUnauUghs

Glosario

Articulación intersectorial: coordinación organizada entre sectores como salud, educación, bienestar social, justicia, migración y cooperación internacional.

Aseguramiento en salud: proceso mediante el cual una persona es afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud, lo que garantiza acceso a servicios, continuidad del cuidado y protección financiera.

Determinantes sociales de la salud: factores sociales, económicos, culturales y ambientales que influyen en la salud de las personas, como la vivienda, educación, empleo, ingresos, entorno y redes de apoyo.

Enfoque diferencial: perspectiva que adapta la atención a las características de grupos específicos (niñez, mujeres, personas mayores, población LGBTQ+, grupos étnicos, víctimas del conflicto, entre otros), garantizando acciones culturalmente pertinentes y libres de discriminación.

Intervenciones colectivas: acciones dirigidas a grupos o comunidades, como educación en salud, jornadas extramurales, promoción de convivencia y fortalecimiento de redes.

Intervenciones individuales: atenciones dirigidas a personas o familias, que incluyen valoración clínica y psicosocial, seguimiento, activación de rutas y remisiones.

Mesas de Articulación Territorial en Salud (MATS): espacios de coordinación entre entidades del territorio para analizar situaciones, definir responsabilidades y organizar respuestas conjuntas en salud pública y migración.

Movilidad humana: proceso que incluye migración, retorno, desplazamiento y tránsito de personas entre territorios, motivado por razones económicas, sociales, familiares o humanitarias.

Rutas de atención en salud: protocolos y pasos definidos para garantizar atención oportuna y continua, que incluyen orientación inicial, atención de urgencias, afiliación cuando aplica, remisiones y seguimiento territorial.

Vigilancia en salud pública: proceso sistemático de recolección, análisis e interpretación de datos epidemiológicos para detectar riesgos, orientar decisiones y activar acciones de prevención y control.

Referencias bibliográficas

ACNUR. (2023). Guía operativa para la atención a personas refugiadas y migrantes en contextos de crisis.

ACNUR. (s. f.). Salud mental y apoyo psicosocial. <https://www.acnur.org/que-hacemos/salvaguardar-los-derechos-humanos/salud-publica/salud-mental-y-apoyo-psicosocial>

Congreso de la República de Colombia. (2006). Ley 1098 de 2006. Diario Oficial. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=22106>

Congreso de la República de Colombia. (2014). Ley 1719 de 2014. Diario Oficial. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=57716>

Congreso de la República de Colombia. (2015). Ley 1751 de 2015. Diario Oficial. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=60733>

Función Pública. (2001). Ley 715 de 2001. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4452>

Función Pública. (2008). Ley 1257 de 2008. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=34054>

Función Pública. (2016). Decreto 780 de 2016. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77813>

Función Pública. (2021). Ley 2136 de 2021.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=168067>

Función Pública. (2025). Ley 2460 de 2025.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=260636>

Instituto Nacional de Salud. (2023). Lineamientos nacionales de vigilancia en salud pública 2023. INS.

<https://www.ins.gov.co/BibliotecaDigital/lineamientos-nacionales-2023.pdf>

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. (2021). Resolución 0971 de 2021.

https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_uaemc_0971_2021.htm

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. (2021). Decreto 216 de 2021.

https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_0216_2021.htm

Ministerio de Salud y Protección Social. (2013). Ley 1616 de 2013.

<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/ley-1616-del-21-de-enero-2013.pdf>

Ministerio de Salud y Protección Social. (2017). Resolución 2063 de 2017.

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%202063%20de%202017.pdf

Ministerio de Salud y Protección Social. (2018). Resolución 3280 de 2018.

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%203280%20de%2020183280.pdf

Ministerio de Salud y Protección Social. (2018). Resolución 4886 de 2018.

<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-4886-de-2018.pdf>

Ministerio de Salud y Protección Social. (2020). Circular 024 de 2020.

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Circular%20No.%2024%20de%202020.pdf

Ministerio de Salud y Protección Social. (2020). Resolución 521 de 2020.

<https://www.minsalud.gov.co/RID/resolucion-521-de-2020.pdf>

Ministerio de Salud y Protección Social. (2021). Decreto 216 de 2021.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=159606>

Ministerio de Salud y Protección Social. (2021). Política de Atención Integral en Salud (PAIS).

<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/lists/bibliotecadigital/ride/de/modelo-pais-2016.pdf>

Organización Internacional para las Migraciones. (2020). Salud mental, respuesta psicosocial y comunicación intercultural. OIM.

Organización Internacional para las Migraciones. (2022). Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2022.

<https://publications.iom.int/books/informe-sobre-las-migraciones-en-el-mundo-2022>

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Diana Rocío Possos Beltrán	Responsable de línea de producción	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Carolina Yusunguirá Ceballos	Experta temática	Centro de Formación de Talento Humano en Salud - Regional Distrito Capital
Eliana Milena Buitrago Umaña	Asesora metodológica	Centro de Formación de Talento Humano en Salud - Regional Distrito Capital
Viviana Esperanza Herrera Quiñonez	Evaluadora instruccional	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Oscar Ivan Uribe Ortiz	Diseñador web	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Jose Yobani Penagos Mora	Diseñador web	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Sebastian Trujillo Afanador	Desarrollador full stack	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Diego Fernando Velasco Güiza	Desarrollador full stack	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Gilberto Junior Rodríguez Rodríguez	Animador y productor audiovisual	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Jorge Eduardo Rueda Peña	Evaluador de contenidos inclusivos y accesibles	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Jorge Bustos Gómez	Validador y vinculator de recursos educativos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima